

SGLT2 억제제 신규 처방 주의사항

SGLT2 Inhibitor — 포시가 (Forxiga · Dapagliflozin) · 자디양 (Jardiance · Empagliflozin) · 슈글렛 (Suglat · Ipragliflozin) · 인보카나 (Invokana · Canagliflozin). 혈당과 함께 심부전·신장도 보호하는 약물이지만 안전 복용을 위해 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.



한눈에 보는 안전 복용 수칙 (Key Safety Numbers)

매일 수분 섭취 1.5~2 L / 일 (탈수 예방)	수술·시술 전 중단 3 일 전 (SSTOP rule)	신기능 사용 가능 eGFR ≥ 30 mL/min · 포시가 25까지 시작 (KDIGO 2024)	생식기 진균 감염 위험 3~5 배 ↑ (위생 관리 필수)
--	---	---	---

SGLT2 억제제는 어떻게 작용하나요? (Mechanism)

신장에서 당 배출 SGLT2 단백질을 차단해 혈당을 소변으로 직접 배출 (하루 50~80g · 200~320 kcal).	혈당·체중·혈압 동시 ↓ HbA1c 0.5~1.0% ↓ · 체중 2~3kg ↓ · 수축기혈압 3~5 mmHg ↓. 저혈당 위험 낮음.	심부전·신장 보호 당뇨 없어도 심부전 입원 ↓ 30% · 신장기능 악화 ↓ 40%. 심혈관·신장 동반 환자 우선 권고.
--	---	---

복용 중 일상 수칙 (Do & Don't)

권장 행동 · DO - 매일 물 1.5~2L — 탈수·저혈압 예방의 핵심 - 회음부 청결 유지 — 배뇨 후 마른 수건, 통기성 속옷 - 정해진 시간에 매일 1회 복용 — 식사와 무관, 아침 권장 - 인슐린·메트포민은 그대로 유지 — 임의로 함께 줄이지 않기 - 정기 혈액검사 (3~6개월) — 신기능·전해질·HbA1c 확인 - 약 이름·용량을 가족·다른 의료진과 공유 — 응급 시 즉시 안내	피해야 할 행동 · DON'T - 임의로 중단·증량 금지 — 'Sick Day Rules' 해당 시만 예외 - 극단적 저탄수화물·키토 다이어트 금지 — 정상혈당 케톤산증 위험 ↑ - 장시간 금식·과음 금지 — 케톤 생성 자극, 탈수 가중 - 더운 날·운동 후 수분 부족 방치 금지 — 어지럼증·실신 위험 - 회음부 통증·홍반·가려움 무시 금지 — 즉시 진료 필요 - 자가 판단으로 이뇨제·NSAIDs 추가 복용 금지 — 신기능 악화 위험
--	--

즉시 약 중단 + 응급실 방문이 필요한 경우 (Red Flags)

SICK DAY RULES · 일시 중단 후 의료진 연락 - 발열·구토·설사로 식사 못 할 때 — 즉시 중단, 회복 후 재개 - 수술·전신마취·수면내시경 3일 전 — SSTOP 룰, 시술 후 재개 24시간 이상 단식·급성 입원 시 — 입원 의료진에 복용 알림	즉시 119 또는 응급실 (CALL 119 / ER) - 정상혈당 케톤산증 — 오심·구토·복통·과호흡·과일향 입냄새 (혈당 정상이어도!) - 푸르니에 괴저 — 회음부·생식기 심한 통증·붓기·홍반 + 발열 (생명 응급) - 심한 탈수·기립성 저혈압 — 실신·8시간 이상 소변 거의 없음
---	---

